HOOFDMATERIAAL

Studieprogramma voor een stage van 12 weken

30–45 minuten per dag, zes dagen per week. Van fysica tot multimodale casussen: elke week één doel, vijf casussen en een korte zelfevaluatie, zodat je goed voorbereid aan elke stage en elke visite begint.

Inhoud

Zo gebruik je dit programma

Herhaling in de tweede periode

Week 1 · Fysisch alfabet en terminologie

Week 2 · Thoraxfoto

Week 3 · Röntgenfoto's van abdomen en skelet

Week 4 · CT hersenen

Week 5 · CT thorax

Week 6 · CT abdomen

Week 7 · MRI van hersenen en wervelkolom

Week 8 · Musculoskeletale en abdominale MRI

Week 9 · Echo van abdomen en oppervlakkige structuren

Week 10 · Doppler en POCUS

Week 11 · Multimodaliteit en spoed

Week 12 · Algemene herhaling en simulatie van de visite

Volgende stap

AAN DE SLAG

Zo gebruik je dit programma

Kort genoeg om vol te houden, zelfs in drukke dienstweken; regelmatig genoeg om een heel jaar mee te gaan.

> *Wat in de opleiding het verschil maakt, is niet één lange studienacht, maar korte, regelmatige herhaling, elke dag op hetzelfde tijdstip.*

Ritme van de week

DAG	TIJD	WAT JE DOET
Maandag–vrijdag	30–45 min	Onderwerp van de dag: lees het betreffende deel, zoek het bijbehorende beeld op in de atlas en los een van de casussen op.
Zaterdag	30–45 min	De resterende casussen van de week en de zelfevaluatie in het weekend.
Zondag	—	Rust. Heb je deze week een dag gemist door een dienst, gebruik deze dan als inhaaldag.

Bij elke casus dezelfde 4 stappen

1. **VOORBEREIDEN** — Identificeer (patiënt, onderzoek, datum, protocol), controleer de kwaliteit (technische adequaatheid), oriënteer je (zijde, doorsnede, venster of sequentie).
2. **DOORLOPEN** — Doorloop elk gebied telkens in dezelfde volgorde. Stop niet bij de eerste bevinding.
3. **BESCHRIJVEN** — Beschrijf met de juiste term (densiteit / signaal / echogeniciteit), lokalisatie, grootte en begrenzing; vergelijk met het eerdere onderzoek en met de contralaterale zijde.
4. **SAMENVATTEN** — Schrijf een conclusiezin, een differentiaaldiagnose en een advies. Vergeet bij een spoedbevinding niet om die te melden.

Houd het Oefenboek bij de hand

Schrijf aan het eind van elke casus drie regels in het Oefenboek: wat je zag, welke term je gebruikte en wat je conclusie is. Aan het eind van de week zijn deze regels je waardevolste herhalingsnotities.

Pas het programma aan je stage aan

- De volgorde van de weken is een voorstel. Loop je nu je neurostage, dan kun je Week 4 en Week 7 naar voren halen; de andere weken volgen in hun eigen volgorde.
- De casussen worden steeds moeilijker. Ook als je de volgorde van de weken verandert, los je de vijf casussen van elke week samen met die week op.
- Verkort op de dagen na een dienst de tijd tot 30 minuten, maar stop niet met het programma. Kort maar regelmatig studeren beklijft beter dan lang maar onregelmatig.
- Vink je voortgang af op het Wekelijkse Voortgangsblad.

TWEEDE HELFT VAN HET JAAR

Herhaling in de tweede periode

Als je de 12 weken hebt afgerond, begin je de cyclus opnieuw; de tweede ronde gaat sneller en selectiever.

1. **Snellere tweede ronde.** Kort de leesdelen in; besteed de meeste tijd aan casussen en je eigen verslagen.
2. **Los eerst op wat je nog niet kon oplossen.** Zet de casussen die je niet hebt afgevinkt op het voortgangsblad, of waar je moeite mee had, aan het begin van elke week.
3. **Neem de tijd op.** Los elke casus op met een stopwatch voordat je naar het antwoord kijkt, en noteer de tijd. Het doel is niet haasten, maar je vaste volgorde automatiseren.
4. **Pas de volgorde aan je stage aan.** Haal in de tweede helft van het jaar de weken naar voren die passen bij de stage die je dan loopt.
5. **Voeg overgeslagen casussen toe.** Verdeel in de tweede ronde de nummers van de 100 Praktijkcasussen die in de eerste ronde niet in het programma zaten over de weken; zo heb je aan het eind van het jaar alle honderd casussen opgelost.
6. **Presenteer hardop.** Vat elke casus hardop in 60 seconden samen, alsof je hem tijdens de visite presenteert.

> **De maatstaf voor de tweede ronde**
>
> Kun je dezelfde casus sneller dan in de eerste ronde presenteren, met minder hiaten en een duidelijkere conclusie, dan ben je op de goede weg.

WEEK 1

Fysisch alfabet en terminologie

Krijg goed onder de knie hoe een beeld ontstaat en met welke woorden je het beschrijft.

Doel van de week

Kunnen uitleggen waardoor helderheid ontstaat op röntgenfoto, CT, MRI en echo, en bij elke modaliteit de juiste term gebruiken (opaciteit, densiteit, signaal, echogeniciteit).

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Beeldvorming bij röntgenfoto en CT; verzwakking en het begrip HU.	Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld
Di	30–45 min	Basisprincipes van MRI: de algemene logica van T1, T2, FLAIR en DWI.	Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld
Wo	30–45 min	Basis van echo: echogeniciteit, akoestische slagschaduw, dorsale akoestische versterking.	Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld
Do	30–45 min	Termen en afkortingen per modaliteit; wat vaak wordt verward.	Het alfabet van het beeld
Vr	30–45 min	De 4-stappenmethode lezen; Casus 1–3.	Gids voor beeldinterpretatie · 100 praktijkcasussen
Za	30–45 min	Casus 4–5 en zelfevaluatie; schrijf de termen in je logboek.	100 praktijkcasussen · Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 1 · Casus 2 · Casus 3 · Casus 4 · Casus 5

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik kan uitleggen waarom lucht, vet, weke delen, bot en metaal er op een röntgenfoto en op CT anders uitzien.
- [ ] Ik kan de termen hyperdens, hyperintens en hyperechogeen aan de juiste modaliteit koppelen.
- [ ] Ik kan zeggen hoe vocht eruitziet op een T1- en T2-gewogen beeld.
- [ ] Ik kan uitleggen waar een akoestische schaduw op wijst en een voorbeeld geven.
- [ ] Ik kan de 4 stappen (VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN) uit mijn hoofd en in volgorde opnoemen.

WEEK 2

Thoraxfoto

Een vaste beoordelingsvolgorde voor het onderzoek dat je tijdens de dienst het vaakst tegenkomt.

Doel van de week

De PA-thoraxfoto en de bedside thoraxfoto elke keer in dezelfde volgorde beoordelen; pneumothorax, effusie, consolidatie en de positie van tubes en katheters niet missen.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Technische kwaliteit (rotatie, inspiratie, penetratie) en normale anatomie.	Deel 02 · Röntgen
Di	30–45 min	Vaste scanvolgorde; Casus 9.	Deel 02 · Röntgen · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Consolidatie, atelectase, effusie; vergelijk in de atlas. Casus 10.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Do	30–45 min	Pneumothorax, cardiomegalie, longoedeem. Casus 11.	Deel 02 · Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Vr	30–45 min	Positie van tubes, katheters en drains; Casus 12.	Deel 02 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 13, zelfevaluatie, verslagsjabloon thoraxfoto.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 9 · Casus 10 · Casus 11 · Casus 12 · Casus 13

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik kan de technische kwaliteit van een thoraxfoto op drie punten beoordelen.
- [ ] Ik kan mijn scanvolgorde opnoemen zonder op papier te kijken.
- [ ] Ik kan de bevindingen opnoemen die consolidatie van atelectase onderscheiden.
- [ ] Ik kan de pleuralijn beschrijven waarnaar je bij een pneumothorax zoekt, en de tekenen van spanning.
- [ ] Ik heb de controle van de endotracheale tube en de tip van de centraal veneuze katheter aan mijn volgorde toegevoegd.

WEEK 3

Röntgenfoto's van abdomen en skelet

Wat gemist wordt op de buikoverzichtsfoto en bij de beoordeling van fracturen opsporen.

Doel van de week

Bevindingen van vrije lucht en obstructie herkennen; een fractuur beschrijven naar locatie, type en dislocatie, en de regel van twee projecties toepassen.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Vaste volgorde op de buikoverzichtsfoto: gasverdeling, vrij lucht, verkalkingen.	Deel 02 · Röntgen
Di	30–45 min	Obstructie van dunne en dikke darm, volvulus; Casus 18.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	De taal van fractuurbeschrijving; bovenste extremiteit. Casus 19.	Deel 02 · Het alfabet van het beeld
Do	30–45 min	Onderste extremiteit, heup, luxaties; Casus 20.	Deel 02 · Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Vr	30–45 min	Fracturen bij kinderen en corpus alienum; Casus 21.	Deel 02 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 22, zelfevaluatie, verslagzinnen bij fracturen.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 18 · Casus 19 · Casus 20 · Casus 21 · Casus 22

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik kan vrij lucht onder het diafragma uitleggen en in welke houding je ernaar zoekt.
- [ ] Ik kan de kenmerken opnoemen die dilatatie van dunne en dikke darm onderscheiden.
- [ ] Ik kan een fractuur beschrijven naar bot, locatie, type breuklijn, dislocatie en gewrichtsbetrokkenheid.
- [ ] Ik kan uitleggen dat een fractuur met één projectie niet uit te sluiten is, en waarom.
- [ ] Bij de beoordeling van een fractuur bij een kind controleer ik de groeischijf apart.

WEEK 4

CT-hersenen

Het belangrijkste onderzoek tijdens de dienst: geen bloeding, CVA of massa-effect missen.

Doel van de week

Een blanco CT hersenen in een vaste volgorde beoordelen in hersen-, CVA- en botvenster; de typen bloeding en vroege tekenen van ischemie herkennen.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Vensters en normale anatomie; vaste volgorde van doorlopen.	Deel 03 · CT
Di	30–45 min	Epidurale, subdurale, subarachnoïdale en intracerebrale bloeding. Casus 26.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Ischemisch CVA: vroege bevindingen, hyperdense arterie. Casus 27.	Deel 03 · CT
Do	30–45 min	Massa-effect, middenlijnverschuiving, hydrocefalus, herniatie. Casus 28.	Deel 03 · Gids voor beeldinterpretatie
Vr	30–45 min	Calvarium en schedelbasis in het botvenster; sinussen. Casus 29.	Deel 03 · CT
Za	30–45 min	Casus 30, zelfevaluatie, verslagsjabloon hersen-CT.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 26 · Casus 27 · Casus 28 · Casus 29 · Casus 30

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik kan een epiduraal en een subduraal hematoom onderscheiden aan de hand van vorm en begrenzing.
- [ ] Ik kan opnoemen waar ik moet kijken bij een subarachnoïdale bloeding.
- [ ] Ik kan de vroege tekenen van ischemie uitleggen en waarom het CVA-venster wordt gebruikt.
- [ ] Ik kan de bevindingen die een massa-effect beschrijven in de juiste volgorde in het verslag zetten.
- [ ] Ik sla het botvenster bij geen enkele CT hersenen over.

WEEK 5

Thorax-CT

Systematische beoordeling in long- en mediastinumvenster; acute thoraxbeelden.

Doel van de week

Een thorax-CT beoordelen in long-, mediastinum- en botvenster; spoedbevindingen als longembolie, aortadissectie en pneumothorax herkennen en een nodulus correct beschrijven.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Vensters, normale anatomie van het mediastinum, vaste volgorde.	Deel 03 · CT
Di	30–45 min	CT-angiografie bij longembolie: contrastfase en vullingsdefect. Casus 35.	Deel 03 · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Aortadissectie en aneurysma. Casus 36.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Do	30–45 min	Nodus, massa, matglas, emfyseem: de beschrijvende taal. Casus 37.	Deel 03 · Het alfabet van het beeld
Vr	30–45 min	Pneumothorax, effusie, thorax bij trauma. Casus 38.	Deel 03 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 39, zelfevaluatie, verslagsjabloon thorax-CT.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 35 · Casus 36 · Casus 37 · Casus 38 · Casus 39

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Bij longembolie controleer ik of het onderzoek voldoende aangekleurd is.
- [ ] Ik weet hoe ik de flap en de uitbreiding bij een aortadissectie beschrijf.
- [ ] Ik kan een nodus beschrijven naar grootte, densiteit, begrenzing en locatie.
- [ ] Ik kan het verschil tussen matglas en consolidatie uitleggen.
- [ ] Bij elke CT thorax houd ik bij of ik alle drie de vensters heb bekeken.

WEEK 6

CT-abdomen

Veelvoorkomende oorzaken van een acuut abdomen en het juiste gebruik van de contrastfasen.

Doel van de week

Op de abdominale CT orgaan voor orgaan in een vaste volgorde werken; appendicitis, diverticulitis, obstructie, vrij lucht, stenen en orgaanletsel door trauma herkennen.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Contrastfasen (arterieel, portaal veneus, laat) en volgorde van doorlopen.	Deel 03 · CT
Di	30–45 min	Appendicitis en diverticulitis. Casus 44.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Darmobstructie en pneumoperitoneum. Casus 45.	Deel 03 · CT
Do	30–45 min	Uretersteen, pancreatitis, cholecystitis. Casus 46.	Deel 03 · Gids voor beeldinterpretatie
Vr	30–45 min	Letsel van solide organen bij trauma; de taal van leverlaesies. Casus 47.	Deel 03 · Het alfabet van het beeld
Za	30–45 min	Casus 48, zelfevaluatie, verslagsjabloon abdomen-CT.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 44 · Casus 45 · Casus 46 · Casus 47 · Casus 48

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Als eerste stap bepaal ik in welke contrastfase het onderzoek is gemaakt.
- [ ] Ik kan mijn volgorde voor het doorlopen van een abdominale CT orgaan voor orgaan opnoemen.
- [ ] Ik heb er een gewoonte van gemaakt om vrije lucht in het juiste venster te zoeken.
- [ ] Ik kan de bevindingen opschrijven die bij appendicitis en diverticulitis in het verslag moeten staan.
- [ ] Ik voeg aan mijn conclusie toe dat de spoedbevinding gemeld moet worden aan de behandelend arts en aan mijn supervisor.

WEEK 7

MRI van hersenen en wervelkolom

Sequenties herkennen en weten wat elke sequentie laat zien.

Doel van de week

T1-, T2-, FLAIR-, DWI- en contrastseries herkennen; acuut infarct, demyeliniserende plaque, massa en myelumcompressie beschrijven.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Sequenties herkennen: het signaal van vocht, vet en bloed.	Deel 04 · MRI · Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld
Di	30–45 min	DWI en acuut infarct. Casus 52.	Deel 04 · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Witte-stoflaesies en MS-plaques. Casus 53.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Do	30–45 min	Massa's: onderscheid intra-axiaal en extra-axiaal, aankleuring. Casus 54.	Deel 04 · Het alfabet van het beeld
Vr	30–45 min	Wervelkolom: hernia nuclei pulposi en myelumcompressie. Casus 55.	Deel 04 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 56, zelfevaluatie, MRI-verslagsjabloon.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 52 · Casus 53 · Casus 54 · Casus 55 · Casus 56

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Als ik een serie open, kan ik aan het signaal van vocht zien welke sequentie het is.
- [ ] Ik weet dat ik diffusierestrictie op DWI samen met de ADC-map moet beoordelen.
- [ ] Ik kan de kenmerken opnoemen die een intra-axiale van een extra-axiale massa onderscheiden.
- [ ] Ik weet dat myelumcompressie een bevinding is die met spoed gemeld moet worden, en hoe ik die beschrijf.
- [ ] Bij MRI gebruik ik het woord «signaal», niet «densiteit».

WEEK 8

Musculoskeletale en abdominale MRI

Basisvolgorde voor de beoordeling van MRI van knie en schouder; veelvoorkomende laesies van lever en hypofyse.

Doel van de week

Banden, menisci en pezen op MRI van knie en schouder in volgorde beoordelen; een veelvoorkomende benigne leverlaesie en een hypofyselaesie beschrijven.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Knie-MRI: normale anatomie en vaste volgorde.	Deel 04 · MRI
Di	30–45 min	Voorste kruisband- en meniscusscheuren. Casus 61.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	MRI schouder: rotator cuff. Casus 62.	Deel 04 · MRI
Do	30–45 min	MRI lever: signaalkenmerken van hemangioom en cyste. Casus 63.	Deel 04 · Het alfabet van het beeld
Vr	30–45 min	Hypofyse en sellaregio; hersenabces. Casus 64.	Deel 04 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 65, zelfevaluatie, verslagzinnen musculoskeletale MRI.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 61 · Casus 62 · Casus 63 · Casus 64 · Casus 65

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik kan de structuren die ik op een knie-MRI beoordeel in een vaste volgorde opnoemen.
- [ ] Ik kan de signaalverandering beschrijven die op een meniscusscheur wijst.
- [ ] Ik kan de pezen van de rotatorcuff bij naam opnoemen.
- [ ] Ik kan de belangrijkste MRI-kenmerken uitleggen die een levercyste van een hemangioom onderscheiden.
- [ ] Een MRI-bevinding waarover ik twijfel, schrijf ik op met een differentiaaldiagnose en een advies, niet als definitieve diagnose.

WEEK 9

Echo van abdomen en oppervlakkige structuren

Een vaste volgorde met de probe in je hand: bekijk elk orgaan in twee vlakken.

Doel van de week

Lever, galblaas, nieren en oppervlakkige organen systematisch doorlopen; galstenen, cholecystitis, hydronefrose, cyste en nodus met de juiste termen beschrijven.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Probekeuze, instellingen, de regel van twee vlakken en de scanvolgorde.	Deel 05 · Echo/POCUS
Di	30–45 min	Lever: steatose, cyste, abces. Casus 70.	Deel 05 · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Galblaas: stenen, cholecystitis. Casus 71.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Do	30–45 min	Nieren: hydronefrose, eenvoudige cyste. Casus 72.	Deel 05 · Het alfabet van het beeld
Vr	30–45 min	Oppervlakkig: schildkliernodus, mammacyste; echo bij appendicitis. Casus 73.	Deel 05 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 74, zelfevaluatie, echoverslagsjabloon.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 70 · Casus 71 · Casus 72 · Casus 73 · Casus 74

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik beoordeel elk orgaan in twee vlakken en neem dat op in mijn verslag.
- [ ] Ik kan de echocriteria van een eenvoudige cyste opnoemen.
- [ ] Ik kan de bevindingen uitleggen die een galsteen van een poliep onderscheiden (slagschaduw, beweeglijkheid).
- [ ] Bij het beschrijven van hydronefrose beoordeel ik ook de contralaterale nier.
- [ ] Ik gebruik de termen voor «echogeniciteit» bij echo correct.

WEEK 10

Doppler en POCUS

Vasculaire en point-of-care-echo op de SEH: snel, gericht, in dezelfde volgorde.

Doel van de week

De basislogica van kleurendoppler begrijpen; DVT, testistorsie en aorta-aneurysma herkennen; eFAST en longecho (A- en B-lijnen) in een vaste volgorde uitvoeren.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Basisprincipes van doppler: kleur, stroomrichting, veelvoorkomende artefacten.	Deel 05 · Echo/POCUS · Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld
Di	30–45 min	Veneuze doppler van de onderste extremiteit en DVT. Casus 78.	Deel 05 · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Scrotale doppler en torsie; aorta abdominalis. Casus 79.	Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Do	30–45 min	eFAST: vensters en vrij vocht. Casus 80.	Deel 05 · Gids voor beeldinterpretatie
Vr	30–45 min	Longecho, pericardeffusie, verdenking op extra-uteriene zwangerschap. Casus 81.	Deel 05 · Echo/POCUS
Za	30–45 min	Casus 82, zelfevaluatie, korte verslagzinnen bij POCUS.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 78 · Casus 79 · Casus 80 · Casus 81 · Casus 82

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Bij de beoordeling van DVT gebruik ik comprimeerbaarheid als basisbevinding.
- [ ] Ik weet dat een verdenking op testistorsie een spoedmelding vereist.
- [ ] Ik kan de eFAST-vensters op volgorde opnoemen.
- [ ] Ik kan uitleggen wat A-lijnen en B-lijnen betekenen.
- [ ] Ik vermeld in mijn verslag dat een negatieve POCUS pathologie niet altijd uitsluit.

WEEK 11

Multimodaal en spoed

Röntgenfoto, CT, MRI en echo bij dezelfde patiënt combineren; dienstscenario's.

Doel van de week

Kunnen bespreken welk onderzoek bij een klinische vraag past; bevindingen uit verschillende modaliteiten samenvoegen in één conclusie en een spoedbevinding op tijd melden.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Van klinische vraag naar onderzoek: de logica van de modaliteitskeuze.	Deel 06 · Multimodale casussen
Di	30–45 min	Traumapatiënt: röntgenfoto, eFAST en CT samen. Casus 87.	Deel 06 · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Neurologische spoed: van CT naar MRI. Casus 88.	Deel 06 · Multimodale casussen
Do	30–45 min	Acuut abdomen: van echo naar CT. Casus 89.	Deel 06 · Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Vr	30–45 min	Scenario's met pijn op de borst en kortademigheid. Casus 90.	Deel 06 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Casus 91, zelfevaluatie, zinnen voor spoedmeldingen.	Oefenboek

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 87 · Casus 88 · Casus 89 · Casus 90 · Casus 91

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik vergeet bij een casus niet om eerdere onderzoeken en andere modaliteiten te vergelijken.
- [ ] Ik kan bevindingen uit verschillende modaliteiten samenvoegen in één conclusie.
- [ ] Ik kan de lijst opnoemen van bevindingen die ik tijdens de dienst met spoed moet melden.
- [ ] Ik heb er een gewoonte van gemaakt om bij twijfel mijn supervisor te raadplegen en dat vast te leggen.
- [ ] Mijn advies geeft rechtstreeks antwoord op de klinische vraag.

WEEK 12

Algemene herhaling en simulatie van de visite

Samenvatting van twaalf weken: vertel elke casus alsof je hem tijdens de visite presenteert.

Doel van de week

De 4 stappen automatisch toepassen bij alle modaliteiten; een casus in 60 seconden presenteren, met een vaste structuur en een duidelijke conclusiezin.

DAG	TIJD	TAAK	MATERIAAL
Ma	30–45 min	Herhaling röntgenfoto: je aantekeningen in het logboek; Casus 96.	Deel 02 · Oefenboek · 100 praktijkcasussen
Di	30–45 min	Herhaling CT; Casus 97 hardop presenteren.	Deel 03 · 100 praktijkcasussen
Wo	30–45 min	Herhaling MRI; Casus 98 hardop presenteren.	Deel 04 · Het alfabet van het beeld
Do	30–45 min	Herhaling echo en POCUS; Casus 99.	Deel 05 · Atlas van de meest voorkomende bevindingen
Vr	30–45 min	Visitesimulatie: multimodale casus met tijdmeting. Casus 100.	Deel 06 · Gids voor beeldinterpretatie
Za	30–45 min	Zelfevaluatie; schrijf je plan voor de tweede periode.	Oefenboek · Wekelijks voortgangsformulier

De 5 casussen van deze week (100 praktijkcasussen)

Casus 96 · Casus 97 · Casus 98 · Casus 99 · Casus 100

Zelfevaluatie in het weekend

- [ ] Ik kan voor elke modaliteit mijn volgorde van doorlopen opnoemen zonder op papier te kijken.
- [ ] Ik kan een casus in 60 seconden presenteren, in een vaste structuur.
- [ ] Mijn conclusiezin, differentiaaldiagnose en advies staan in elke casus.
- [ ] Ik heb de onderwerpen waar ik moeite mee had bepaald en in de eerste weken van de tweede periode gepland.
- [ ] Ik heb de nummers van de 100 Praktijkcasussen die ik niet heb opgelost voor de tweede ronde op een lijst gezet.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open vandaag Deel 01 · Het fysische alfabet van het beeld en begin met de maandagtaak van Week 1. De eerste 30 minuten bepalen het ritme van de rest van het jaar.

Ga ter voorbereiding op de visites voor de vragen die bij het onderwerp van elke week passen naar **300 vragen voor de visite en het mondeling examen**: werk daarin en noteer je voortgang in **Wekelijks voortgangsformulier** door af te vinken.